

一次好的督導， 是同理之海中的一座工作之島

EFT 督導模式的基本向度：
能力、目標、督導者回應與事件本位模式

依據 Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. APA. (第2章，pp. 29–43)

碩士層級臨床心理學教材

讀完這份資訊圖，你能夠……

1. 描述五大能力向度與五項督導目標
2. 把督導者的回應分進四類（含歷程引導的五種子類型）
3. 判斷何時必須改用內容指導，例如自殺風險
4. 把一次督導切成五步驟的事件序列
5. 辨識標記的四種來源，並準備自己的督導標記
6. 說明「受督者歷程才是改變的所在」

銜接單元 1

單元 1 談督導的理論與原則；本單元談督導由哪些部分組成、如何展開。

EFT 督導的三個基本向度

① 能力與目標

督導要培養受督者的什麼？

② 督導者的參與方式

督導者用哪些回應來促進學習？

③ 事件本位模式

一次督導事件由哪些步驟組成？

對受督者的意義

懂得督導的結構，就能從「被指導」轉為主動參與督導。

這個模式從哪裡來？

任務分析

Greenberg (1984) 用來理解
心理治療改變事件的方法

事件本位典範

Ladany、Friedlander 與
Nelson (2005, 2016) 的督
導事件模式

EFT 督導的主要組成

督導同盟

人際技能

技術技能

個人化

作者的期待

讓督導地圖更清楚；成為辨識、理解，最終研究督導關鍵成分的
範本。

為什麼要把能力與目標說清楚？

對督導者

能系統性地組織大量資訊，讓目標得以達成、能力得以發展。

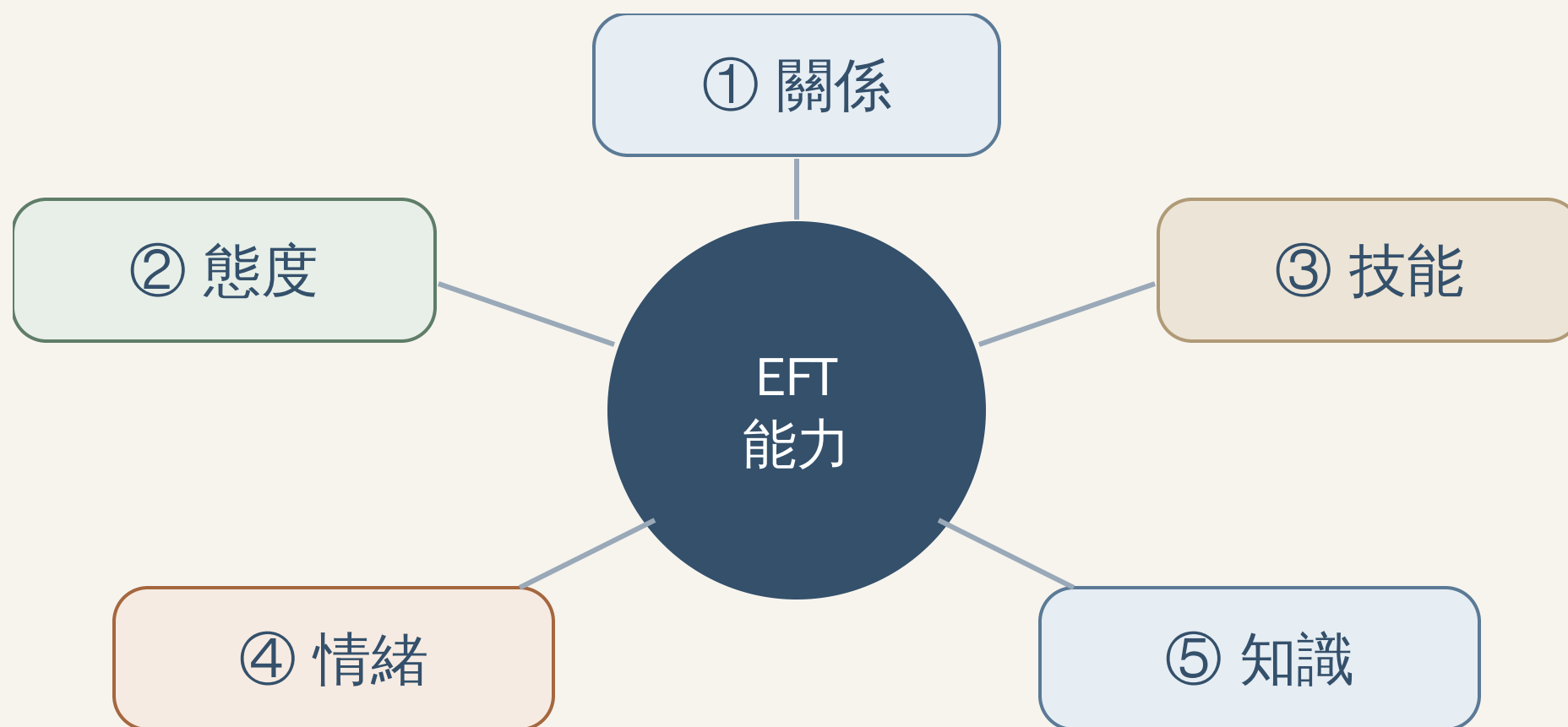
對雙方

提供共同基礎：一起決定督導中最重要的面向，並選擇性地聚焦。

臨床上要問什麼？

這學期我最想在哪一個能力向度上成長？督導者知道嗎？

EFT 的五大能力向度



容易誤解

EFT 訓練不只是教技術：態度與情緒各自是獨立的能力向度。

關係能力

建立並維持正向、成長導向、真誠的治療關係。

在場

完整地與個案同在當下

個人溫暖

讓個案感受到被接納

同理

理解並傳達個案的經驗

慈悲

對個案的痛苦懷有關懷

在晤談中看起來像

個案感到被理解，願意說出更多。

態度能力

好奇

真誠的好奇心

正向人觀

所有人都值得被愛
與尊重

相信改變

改變是可能發生的

其他目標態度

- 對經驗開放
- 高度容忍模糊
- 提升自我覺察
- 社會覺察：欣賞多元、正直

臨床上要問什麼？

概念化還不清楚時，我能不能忍住不急著下結論？

技能能力：四類

(a) 知覺、概念、介入
看見、理解，並做出回應

(b) 表達技能
傳達同理、投入他人、讓人自在、建立關係、傳達尊重

(c) 歷程技能
調頻的傾聽、歷程診斷、概念化

(d) 進階介入技能
完成不同治療任務所需的技能

一句話

不只知道做什麼，還要知道何時做、怎麼讓對方感受到。

情緒能力

覺察情緒，並讓情緒為合理的行動提供資訊。

情緒覺察

覺察自己與他人的情緒

情緒運用

取用或產生感受，以促進思考

情緒知識

理解情緒

情緒管理

忍受情感；調節自己與他人的情緒

在晤談中看起來像

個案崩潰時，治療師能穩住自己，仍然在場。

知識能力

專業知識

EFT 與情緒文獻中的相關資料與理論

但原教材說，最重要的是：

對自己與他人的認識

知道自己在哪些情緒面前會退縮、在哪些時候容易想「幫忙解決」。

銜接單元 1

Greenberg 建議個人治療，不是為了反移情，而是處理自己的情緒能擴大處理他人情緒的能力。

EFT 督導的五項目標

1 成長導向、真誠、信任的關係

2 提升受督者的臨床能力

3 維護個案福祉，促進個案改變

4 確保合乎倫理的專業實務

5 (依場域而定) 評量表現

目標①：成長導向的關係

一段成長導向、真誠、信任的關係，協助受督者：

建構價值

形成自己的心理治療價值觀

專業認同

依據這些價值發展專業認同

督導者也在示範

整體督導經驗都在影響受督者，所以督導者要示範所教的內容：
情緒覺察、同理、批判思考與成長。

目標②：以優勢為基礎， 改善弱點

(a) 人際技能

與個案形成連結、維持合作同盟

(b) 歷程診斷

辨識治療標記，與個案合作朝向任務

(c) 技術技能

介入、概念化、個人化；在跟隨與引導中共構

(d) 情緒促進

知覺、取用、理解、調節、轉化情緒；也為日後自己擔任督導者奠定經驗基礎

目標③④：個案永遠在場

③ 個案福祉與改變

始終以個案的最佳利益為念，協助個案朝向解決，達到更符合內外
在安適狀態的調適。

④ 合乎倫理的專業實務

確保個案的安全與最佳臨床結果。

臨床上要問什麼？

這次督導討論的內容，最後有沒有回到個案的福祉？

目標⑤：評量，但學習優先

依場域而定，督導者可能負責監督受督者的發展程度與進階準備度，並提供形成性回饋。

原教材的優先順序

受督者的學習、成長與發展，優先於正式的進展評量，以提供最佳的學習環境。

信念：每個人都有成長的內在資源，種子需要沃土。

容易忽略（延伸）

學習優先，不代表評量不存在。清楚說明評量什麼、如何評量，受督者才敢揭露困難。

督導的兩個面向

關係經驗面向

兩個人之間的相遇，在持續的「我—汝」對話中轉化彼此（參照 Buber）。對建立同盟而言最重要。

技術、目標導向面向

個案的治療仍是雙方在一起的核心目的；督導要實質促進個案福祉。

一句話

關係是基礎，個案是目的。兩者並存，不互相取代。

EFT 督導不是什麼？

✗ 個案回顧

不停留在口頭報告個案資料，而是看錄影中的實際歷程。

✗ 對受督者的替代性治療

不以治療受督者在晤談中被觸發的個人議題為焦點。

✗ 權威、僵化的指導

不像某些手冊化治療那樣要求僵化地遵從。

督導者的主要角色

支持與溫和的引導；推進受督者學習促進個案經驗與情緒處理的方法。

督導者的四類回應

偏好經驗性回應，並協助探索受督者的兩難（參照 Elliott 等，2004）。

① 同理探索

傳達理解，協助看得更清楚

② 歷程引導

引導歷程，而非內容

③ 經驗性在場

調頻、珍視、真誠、合作

④ 內容指導

建議、保證、資訊性提問

同理探索回應

傳達理解，同時協助受督者從模糊、正在浮現的邊緣，更清楚地感覺到個案在溝通、感受與需要什麼。

探索性問句

契合問句

歷程觀察

同理臆測

同理重新聚焦

原書示例

「我看到你的回應是在驗證那份痛，而不是個案聲音裡的憤怒。我好奇那一刻發生了什麼，是什麼讓你這樣決定？」

重點

不直接糾正，而是好奇受督者的決策歷程。

歷程引導：引導歷程，而非內容

✗ 內容式的指揮

直接告訴受督者要做什麼，違反任務合作與自我發展的原則。

✓ 歷程引導

提供如何在特定治療任務上有成效地工作的建議。

下一頁

歷程引導有五種子類型：經驗性概念化、書籤標記、經驗性教學、結構化任務、歷程建議。

歷程引導的五種子類型

子類型	做什麼
(a) 經驗性概念化	以經驗性語彙概念化個案的議題
(b) 書籤標記	標出某個經驗或任務值得日後處理
(c) 經驗性教學	說明經驗或治療歷程的本質
(d) 結構化任務	提出任務，或建議如何進入、完成任務
(e) 歷程建議	教練式地鼓勵嘗試特定介入，例如澄心聚焦、椅子工作

結構化任務回應： 先肯定，再給方向

原書示例

督導者注意到受督者大量依賴同理回應：

「我喜歡你傳達同理的方式，但你需要在回應中多一些結構，把我們的任務放在心上。你可以轉向椅子工作，喚起個案對失落的情緒。」

覺察作業

請受督者分析自己的錄影片段，辨識標記、個案的情緒反應、可能的任務、相應的介入回應，以掌握治療中的微歷程。

經驗性在場回應

透過調頻、珍視、真誠與合作傳達，目的是培養督導同盟。

歷程揭露

例：表達對受督者某個介入的興奮

個人揭露

運用個人或專業上的例子與經驗，作為教學手段

原書示例：聽錄影時的小小鼓勵

「傾聽和跟隨得很好。」 「太好了！」 「我喜歡這個！」

內容指導回應

問題解決式的建議、專家式的保證、資訊性問句。

「最少內容指導」原則

EFT 偏好經驗性回應，但任何督導都涉及一定程度的個案管理，所以內容指導無可避免。

必須直接指導的時候

- 執行倫理行為
- 建立治療設置
- 個案的自殺風險，或嚴重的情緒調節不良
- 界線違反：不出席、付費問題、送貴重禮物

安全先於歷程

原書示例：督導者先要求受督者在晤談中做簡要的自殺風險評估，並具體詢問：

除了想死的幻想，還知道什麼？

念頭是主動還是被動？

多常出現？

有沒有計畫？考慮什麼手段？

還有哪些保護因子？

對受督者（延伸）

風險與倫理議題要在督導一開始就提出，不要留到最後。

對話：在受督者的參照架構中提問

改編自 Glickauf-Hughes & Campbell (1991) 的經驗性團體督導取向

✗ 督導者的架構

「就是這樣。」

✓ 受督者的架構

「你怎麼想？」

不直接給答案，而是用提問協助受督者得出個人化的答案，信任自己的感受、知覺與介入。

需要敏感於

受督者的理論背景（例如先受過認知行為或心理動力訓練）；個人、文化與專業視角；找到共通的語言。

以自我為工具

受督者在晤談中的感受，是個案可能正在發生什麼的指標。

辨識那一刻的感受 → 深化它 → 從意義中學習

目的：讓受督者更經驗性地覺察自己的感受，並把它們用在治療目的上。

界線

探索的是「這份感受如何幫助理解個案」，不是深入受督者的個人議題。

微歷程引導與示範

歷程建議與微歷程引導

除了跟隨，督導者也提出建議：不同的回應方式、似乎正在出現的標記、可以用來深化經驗的介入。

示範的兩個層次

直接示範：在督導中現場演示介入或回應。

態度示範：督導者如何對待受督者、如何看待個案的困難，本身就是教學。

每一個督導事件的五個步驟



每個事件都有可辨識的開始、中間與結尾，並鑲嵌在同理的合作關係中。

標記決定焦點

人際或同盟困難（與個案，或與督導者），或是某項介入技能上的技術困難。

同理之海中的工作之島

同理支持與驗證之海

事件：同盟

事件：概念化

事件：椅子工作

時間尺度

有的事件在一次督導內完成；有的延續多次督導，甚至持續整個督導歷程。

擴展模式：從標記開始

A. 受督者提出的困難

人際：低同理、同盟弱

技術：介入、個案概念化

B. 督導同盟困難

對質

退縮

任務環境：督導者的操作

督導者的角色與風格：同理探索、經驗學習對話、示範、角色扮演。

原圖為流程圖，此處依可辨識的內容改寫重構。

擴展模式：走向解決

改變歷程

受督者的歷程：投入

(a) 督導同盟改善

雙方積極而有成效地投入督導關係

(b) 技能提升

人際：同理，以及傳達

Rogers 核心條件的能力

技術：知識提升、使用新介入、理解個案的核心情緒基模、發展個人的介入風格

先接觸，再訂契約

歡迎受督者，營造友善安全的氛圍；簡短了解他的狀況、心理狀態、精力，以及任何可能成為阻礙的事。接著才合作協議這次的焦點。

原書示例

督導者：「嗨，很高興你又來了。今天感覺怎麼樣？感冒好一點了嗎？」

受督者：「好多了，謝謝。上次晤談有件事讓我一直在想。」

接著

「今天想談什麼？」進入工作階段，開始聽錄影。

督導的材料是錄影， 不是口頭報告

所有督導都使用錄影

最好是影像，讓受督者的實際表現成為督導焦點。

督導者先清空自己

放下先前在做的事、擱置無關的擔憂，盡可能在場。

新個案的背景資料

主訴、個案史、基本資料：只作為定向，不是督導的依據。

標記的四種來源

來源	原書示例
① 受督者的兩難	「我該做椅子工作，還是澄心聚焦？」
② 受督者的擔憂	「我擔心我漏掉了什麼。」或在椅子上不自在地挪動
③ 直接請求協助	「今天我想聚焦在我的椅子工作技術上。」
④ 督導者看到的教學點	錄影中被忽略的標記、任務、情緒或情緒底音

對受督者
一個模糊的擔憂，甚至一次不自在，都是正當的起點。

人際困難，還是技術困難？

人際困難（與個案）

「我就是覺得沒跟個案連結上。」

「個案看起來很戒備。」

技術困難（介入）

「我沒辦法幫個案深化感受。」

「我不知道怎麼幫她把憤怒說出來。」

「我抓不到個案核心的批評。」

多個標記同時出現

例如同盟困難、缺乏焦點、辨識不出標記。先處理哪一個，合作決定。

當困難發生在督導關係裡

受督者端的標記

對質：表達對督導的不滿

其他：退縮、無助、防衛、對立

督導者也可能需要對質

例如遲到，或某項正在干擾治療的個人或技術弱點。

預告

第 4 章（單元 4）會詳述同盟裂痕的標記與修復。

任務環境：督導者在標記處的回應

督導者的表現就是任務環境。

原書示例

協助受督者持續聚焦於個案的核心議題；教解決未竟事務的步驟。

錄影讓督導者「直接見證」

個案與受督者說了什麼、怎麼說、接下來的回應是什麼。

研究焦點

值得關注的是：為了處理這個督導任務而做的回應與介入。

改變的所在， 是受督者的歷程

受督者的歷程，比督導者做了什麼更重要。

督導者的介入要有效，必須促進受督者的投入與發展。成功的督導，取決於督導者能否促進受督者的學習。

臨床上要問什麼？

這次督導後，受督者（或我）新看見了什麼、能做到什麼？

受督者學到的，可能是……

技能	原書示例
知覺	開始聽見個案聲音品質的改變：他正進入更觸動的經驗
介入	學會讓個案聚焦於當下身體感受的新技能
概念	理解個案常把自己的自我批評歸因於他人（經由雙椅對話與督導者指出）

原教材承認的限制

這些複雜的認知、情感與行為歷程如何帶來改變，尚未被清楚研究。

解決的兩種形式

(a) 督導同盟改善

雙方積極而有成效地投入督導關係。

(b) 技能提升

人際：更在場，有更好的同理、溫暖、正向關懷與一致性

技術：能使用新介入，理解個案的核心情緒

成功督導的結果：新的理解；知覺、理解、態度與技能的整合；行動計畫。

技能提升發生在五個領域

領域	受督者變得……
治療同盟	更能積極而有成效地投入治療關係
知覺技能	以新的方式看見個案的表現與經驗
個案概念化	對個案的主題與運作模式有洞察的理解
介入技能	能及時、流暢、有創意地使用新介入
個人化	感到被鼓勵、被啟發而成長

怎麼知道解決了？

原書示例

受督者對個案的憂鬱組織產生經驗性的新理解：看見次發的無望與悲傷可能遮蔽了底下的憤怒，並看見核心憤怒的適應面。

主觀指標

雙方都感到鬆一口氣與滿足，並帶著重新燃起的熱情，繼續為個案工作。

若沒有解決

問題會在後續督導中反覆出現 → 同盟裂痕迫在眉睫 → 公開討論目標與期待，重新組織任務。

督導與治療的平行結構

治療中	督導中
個案標記（例：未竟事務）	受督者標記（例：抓不到核心批評）
治療任務（例：空椅對話）	督導任務（例：示範、練習回應）
個案的改變歷程	受督者的學習歷程
解決（例：原諒、追究責任）	解決（同盟改善、技能提升）

本頁為本教材依原書內容所做的整理。

島與海

「在同理支持與驗證之海中的
工作之島。」

“islands of work within an ocean of empathic support and validation.”

臨床意義

技術性的工作事件，永遠被同理的關係包圍。

教學重點

這次督導有清楚的焦點嗎？我感到被支持嗎？

改變在哪裡發生

「督導中受督者的歷程才是改變的所在；它們比督導者做了什麼更重要。」

“it is supervisee processes in supervision that are the site of change; these are more important than what the supervisor does.”

臨床意義

與治療平行：改變發生在經驗歷程中，而不是技巧中。

教學重點

受督者的主動參與，是督導有效的必要條件。

督導的兩條界線

「EFT 督導既不是個案回顧，
也不是對受督者的替代性治療。」

“EFT supervision involves neither a case review nor a surrogate therapy for the supervisee.”

臨床意義

焦點是錄影中的實際歷程，以及促進個案經驗的技能。

教學重點

帶錄影，不只帶摘要；個人議題考慮個人治療。

六個常見誤解

常見理解	更精確的理解
EFT 督導從不直接指導	風險與倫理議題必須內容指導
督導就是報告個案	督導的材料是錄影中的實際歷程
只有受督者能提出標記	督導者看到的教學點也是標記
督導者講得越多越好	改變的所在是受督者的歷程
能力 = 技術	還包括態度、情緒與自我認識
沒解決就算了	反覆未解決是裂痕的預警

「我在督導最後五分鐘，
才提到個案說過想死。」

✗ 錯在哪裡

風險議題被排在錄影討論之後，錯過了督導者給予具體指引的時間。

✓ 修正

在關係接觸之後、確認焦點之前先提出。督導者會轉為內容指導：念頭的性質、頻率、計畫、手段、保護因子，以及機構的流程。

原則

安全先於歷程。

檢查一下你記住了什麼

Q1 督導者說：「這個經驗值得我們之後再回來處理。」這是歷程引導的哪一種子類型？

Q2 受督者說：「我不知道怎麼幫個案把憤怒說出來。」這是人際困難，還是技術困難？

Q3 事件模型的五個步驟依序是什麼？

Q4 同一個困難連續三次督導都沒有解決，意味著什麼？該怎麼做？

解答與一句話說明

A1 書籤標記。標出某個經驗或任務，值得日後注意。

A2 技術困難。這是某項介入技能上的困難；但也要留意受督者是否對憤怒感到不自在。

A3 關係接觸 → 標記 → 任務環境 → 受督者歷程 → 解決。

A4 同盟裂痕的預警。公開、真誠地討論目標與期待，重新組織任務。

在督導標記處的八個步驟

1 受督者說了什麼？

2 我還不知道什麼？

3 人際、技術或同盟？

4 有其他解釋嗎？

5 回看錄影來驗證

6 選擇任務環境

7 投入，還是順從？

8 解決的樣子？

第 0 步

先問：有沒有安全或倫理議題？

一次督導的決策流程



有

內容指導：具體的評估與處理步驟

沒有

合作確認標記 → 選擇任務環境

標記類型	主要任務環境
人際	同理探索受督者的經驗、在場回應
技術	歷程引導、示範、練習
督導同盟	真誠、共同承擔、公開討論

把困惑整理成一個督導標記

項目	填寫什麼
片段時間點	錄影第幾分鐘
發生了什麼	個案說了什麼、怎麼說；我回應了什麼
困難屬於	人際？技術？我自己的反應？不確定？
標記形式	兩難、擔憂或直接請求
想要的協助	示範、一起聽、練習、理解概念

安全或倫理議題
在督導一開始就提出。

這對實務意味著什麼？

面向	本單元的意涵
準備督導	帶一個具體標記與錄影片段
評估能力	五大向度，不只看技術
風險	督導轉為內容指導；及早提出
關係	學習優先於評量；不是個案回顧，也不是替代性治療
成效	看受督者學到什麼
同盟	反覆未解決，就要公開討論

哪些主張有證據？

主張	證據性質
以任務分析理解改變	Greenberg（1984）的方法論；用於督導是本書的提議
督導事件可被辨識與解決	Ladany 等人分析督導逐字稿；非 EFT 督導研究
五步驟事件模型	作者提出的啟發性模式，尚未實證檢驗
受督者歷程是改變所在	理論主張；學習機制尚未被研究
風險時需要內容指導	專業實務與倫理要求

還沒有答案的問題

1. 「學習優先於評量」，和守門責任之間的張力如何處理？
2. 受督者的學習歷程機制不明，怎麼判斷督導真的有效？
3. 督導者與受督者對標記的判斷不同時，由誰決定？
4. 「最少內容指導」的界線在哪裡？除了自殺與界線議題，還有哪些情況？
5. 沒有錄影的場域，這個模式還能怎麼用？

四個層次的學習

必須記住

5 能力、5 目標、4 類回應、
歷程引導 5 種子類型、事件 5
步驟、標記 4 來源、解決 5
領域

必須理解

學習優先於評量；督導不是回
顧或治療；受督者歷程是改變
所在；風險需要內容指導

必須能夠應用

把督導切成五步驟；分類督導
者回應；準備自己的標記

必須能夠質疑

模型尚未實證；學習機制不
明；評量與學習的張力

帶一個標記進督導， 讓督導成為你的工作之島。

主要來源：Greenberg, L. S., & Tomescu, L. R. (2017). *Supervision Essentials for Emotion-Focused Therapy*. Washington, DC: American Psychological Association. 第2章 (pp. 29–43)。

原書引用：Greenberg (1984)；Ladany, Friedlander, & Nelson (2005, 2016)；Bernard & Goodyear (2013)；Elliott, Watson, Goldman, & Greenberg (2004)；Glickauf-Hughes & Campbell (1991)；Buber (1958)。

表格與列表皆經改寫整理；引文為短句並附頁碼。

下一單元：督導的歷程（第3章）